

Pie Diabético

Definición y Patogenia

Presencia de una lesión/úlceras o antecedente de esta, o cualquier factor que confiera un muy alto riesgo (neuropatía, isquemia, deformidades). **Multifactorial:** 1. **Neuropatía:** Pérdida de sensibilidad e hidratación plantar. 2. **Vasculopatía:** Isquemia (Macro y microangiopatía). 3. **Inmunosupresión:** Predisposición a infecciones severas y polimicrobianas.

Clasificación Clínica (Grados de Gravedad)

- **Grado 0:** Sin lesión, pero con deformidad ortopédica y/o vasculopatía/neuropatía (Pies en riesgo). - **Grado 1:** Úlcera superficial (piel y tejido celular subcutáneo). - **Grado 2:** Úlcera profunda que alcanza ligamento, tendón, músculo o fascia (fasciitis necrotizante). - **Grado 3:** Úlcera profunda con **osteomielitis**, formación de abscesos o compromiso articular. - **Grado 4:** Gangrena localizada (ej. un dedo). - **Grado 5:** Gangrena extensa de todo el pie.

Enfrentamiento y Manejo

El manejo incluye prevención (control glicémico, calzado adecuado, podología preventiva) y manejo específico de úlceras.

TABLA 2.16.1: NIVEL DE LESIÓN VS MANEJO ESPECÍFICO	
NIVEL DE LESIÓN	MANEJO ESPECÍFICO
Grado 1 y 2 leves	Curaciones, manejo de factores de riesgo, uso de dispositivos de descarga de presión. Si hay signos de infección: Antibióticos.
Grado 2 profundo (Fasciitis)	Debridamiento quirúrgico amplio (de preferencia).
Vasculopatía concomitante	Evaluar revascularización (bypass vascular periférico o angioplastia) si hay isquemia crítica para evitar amputación.
Grado 3 (Osteomielitis) o 4/5	Frecuentemente requiere amputación .

Reglas para la Amputación

1. Resecar la totalidad del área infectada/necrótica. 2. Extraer todo hueso comprometido. 3. Procurar respetar las uniones articulares dentro de lo posible para favorecer futuras ortesis, aunque sacrificando estética a favor del control infeccioso.

Diagnóstico de Osteomielitis subyacente

Si hay compromiso óseo, es indicación central de amputación. Se diagnostica mediante: 1. **Clínica:** Posibilidad de llegar al periostio y palpar el hueso con sonda metálica a través de la úlcera (*Probe to bone test*). 2. **Radiografía de Pie:** Primer examen de estudio, descartará lesiones evidentes (menos sensible). 3. **Resonancia Magnética:** Prueba de elección y más sensible/específica cuando hay duda.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es el principal factor fisiopatológico en el desarrollo del pie diabético?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Pie Diabético. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El pie diabético es la principal causa de amputación no traumática
- La neuropatía periférica es el factor más importante (>80% de los casos)
- El monofilamento de 10 g (Semmes-Weinstein) es el test de tamizaje estándar
- Clasificación de Wagner: grados 0-5 según profundidad y extensión
- Wagner 3: osteomielitis; Wagner 4: gangrena localizada; Wagner 5: gangrena extensa
- El tratamiento incluye descarga, debridamiento, antibióticos y control glicémico
- La prevención con educación e inspección diaria es fundamental

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PIE DIABÉTICO)

PREGUNTA 1

¿Cuál es el principal factor fisiopatológico en el desarrollo del pie diabético?

- ☐ A) Enfermedad arterial periférica
- ☐ B) Neuropatía periférica
- ☐ C) Infección bacteriana
- ☐ D) Insuficiencia venosa
- ☐ E) Hiperglicemia aguda

PREGUNTA 2

Paciente diabético con úlcera en el pie que compromete hasta el tendón, sin absceso ni osteomielitis. ¿Cuál es la clasificación de Wagner?

- ☐ A) Wagner 1
- ☐ B) Wagner 2
- ☐ C) Wagner 3
- ☐ D) Wagner 4
- ☐ E) Wagner 0

PREGUNTA 3

¿Cuál es el instrumento de tamizaje estándar para evaluar neuropatía periférica en el pie diabético?

- ☐ A) Electromiografía
- ☐ B) Monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 g
- ☐ C) Doppler arterial
- ☐ D) Radiografía de pie
- ☐ E) Termografía

RESUMEN: PIE DIABÉTICO

El pie diabético es una de las complicaciones más devastadoras de la diabetes y la principal causa de amputación no traumática de extremidades inferiores. Se produce por la combinación de neuropatía periférica (que causa pérdida de sensibilidad protectora), enfermedad arterial periférica (que compromete la perfusión) y susceptibilidad a infecciones. La neuropatía es el factor más importante, presente en más del 80% de los casos. La evaluación debe incluir inspección visual de los pies, evaluación de la sensibilidad con monofilamento de 10 g (test de Semmes-Weinstein) y diapasón de 128 Hz, palpación de pulsos pedios y tibiales posteriores, y cálculo del índice tobillo-brazo si se sospecha enfermedad arterial. La clasificación de Wagner categoriza las úlceras en grados 0 a 5: grado 0 (pie de riesgo sin úlcera), grado 1 (úlcera superficial), grado 2 (úlcera profunda hasta tendón o cápsula), grado 3 (úlcera con absceso u osteomielitis), grado 4 (gangrena localizada) y grado 5 (gangrena extensa). El tratamiento incluye descarga de presión (off-loading), debridamiento del tejido necrótico, antibioterapia según la severidad de la infección, control glicémico, revascularización si hay isquemia significativa, y cuidado avanzado de heridas. La prevención es fundamental: educación al paciente, inspección diaria de los pies, calzado adecuado, cuidado podológico regular y control de factores de riesgo.